



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA TAHUHAN
TIM HIV/AIDS RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA TAHUNAN TIM HIV/AIDS RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam waktu yang singkat virus human immunodeficiency virus (HIV) telah mengubah keadaan sosial, moral, ekonomi dan kesehatan dunia. Saat ini HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan terbesar yang dihadapi oleh komunitas global.

Saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini menekankan kemudahan akses bagi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk mendapatkan layanan pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, sehingga diharapkan lebih banyak orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) yang memperoleh pelayanan yang berkualitas. Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan standar pelayanan bagi rujukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan satelitnya dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

1. meningkatkan fungsi pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)
2. meningkatkan fungsi pelayanan Prevention Mother to Child Transmision (PMTCT)
3. meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART) atau bekerjasama dengan RS yang ditunjuk
4. meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)
5. meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor risiko Injection Drug Use (IDU)
6. meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi: pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas. Program prioritas tersebut yaitu menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS. Sesuai dengan standart nasional akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, bahwa setiap rumah sakit melaksanakan program pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit Prima Husada melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Rumah Sakit Prima Husada menyusun program kerja Tim Hiv Aids rumah sakit prima Husada.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Dan Tes Hiv.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/MENKES/PER/II/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran;
10. Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Departemen Kesehatan RI Tahun 2007;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 192.1/I-KEP/DIR/IV/2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 037/DPM/I-KEP/DIR/II/2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Tujuan Umum

Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman rujukan ODHA

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan fungsi pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing)
- b. Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmition)
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi oportunistik (IO)
- d. Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor resiko IDU
- e. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium, radiologi, pencatatan dan pelaporan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan Seluruh Lapisan Masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

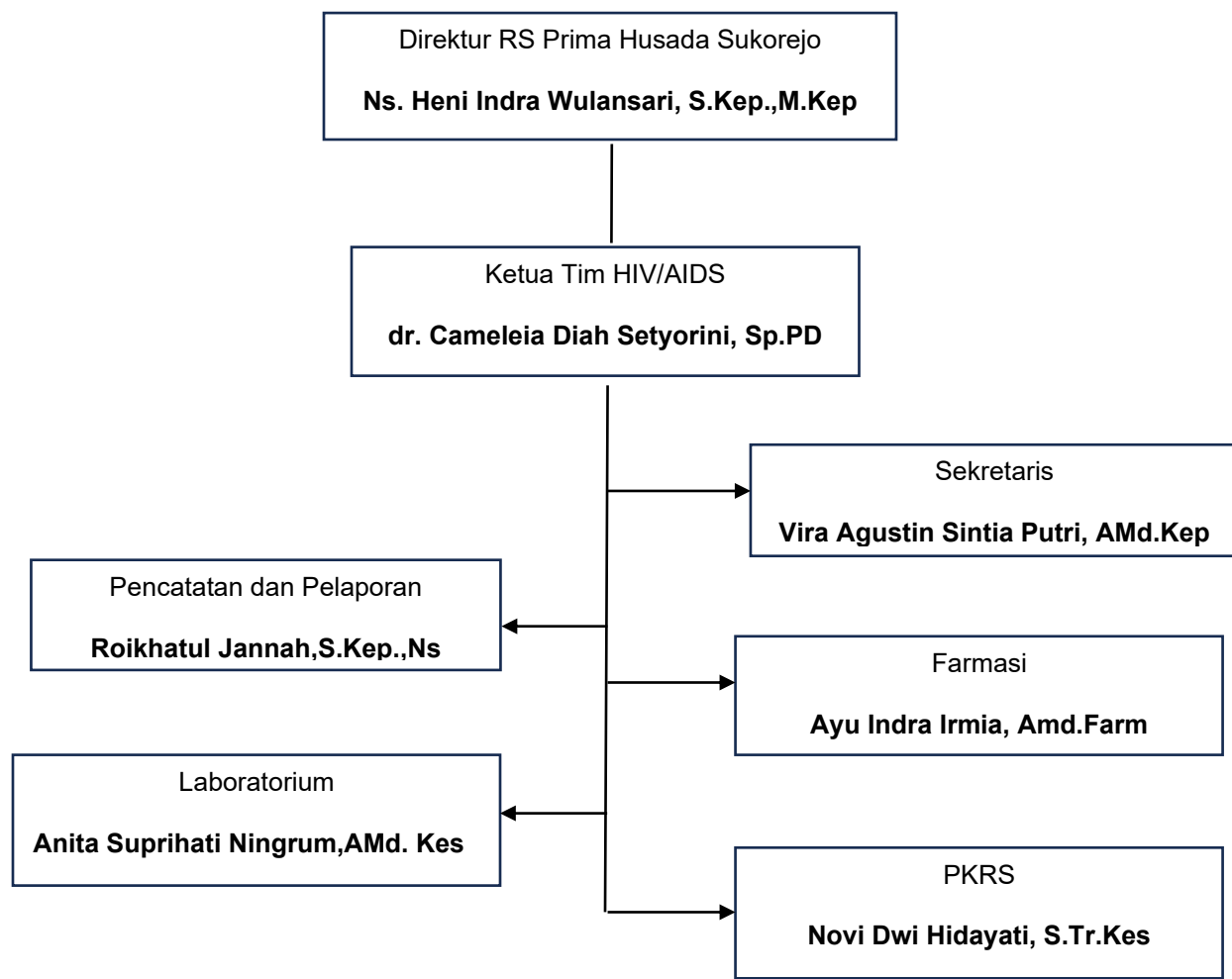
2.3 Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit



BAB III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Jabatan	Jumlah SDM														Ket.
	Analisis Beban Kerja	Bulan Ke-												Kebutuhan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ketua Tim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Terpenuhi
PJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Terpenuhi
RR/ RM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Terpenuhi
Laboratorium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Terpenuhi
Farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Terpenuhi

Analisa
Dari tabel diatas tampak bahwa kebutuhan tim HIV/AIDS adalah 5 orang namun yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan.

3.1.2 Orientasi

Pada tahun 2025 tidak ada orientasi

3.2 Kinerja Produktifitas

3.2.1 Asal Permintaan Tes Hiv

Tes HIV dilakukan jika permintaan dari IRJA, IRNA, DLL yang dicurigai terpapar HIV. Hal ini dilakukan untuk menskrining pasien-pasien di Rumah Sakit dengan cara pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter, apabila ditemukan tanda gejala HIV maka pasien dilanjutkan dengan pemeriksaan HIV dengan mengisi form pemeriksaan HIV, apabila hasil positif maka pasien dilakukan perawatan dengan pemberian ART, seperti yang tampak pada tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1
Data Asal Permintaan Tes HIV (Orang yang dicurigai terpapar HIV) tahun 2025 di RS Prima Husada Sukorejo

No	UNIT / KLINIK ASAL PERMINTAAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Poli Penyakit Dalam (PITC)	4	2	3	2	3	5	7	3	4	5	2	1	41
2	Poli Paru (PITC)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
3	Poli Penyakit Kandungan (PMTCT)	2	0	0	2	0	2	1	1	1	2	4	3	18
4	IGD (PITC)	18	12	26	27	11	16	13	16	19	18	16	9	201
7	Poli Umum (PITC)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	Poli Kulit dan Kelamin (PITC)	2	1	1	0	2	1	2	1	1	3	2	0	16
9	Instalasi Rawat Inap (PITC)	14	8	9	9	16	15	24	13	10	16	14	22	170
10	Laboratorium (PITC)	0	2	0	0	3	0	2	4	2	2	3	0	18
11	Poli Anak (PITC)	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5
	Total PITC													
	Total	43	26	41	40	36	39	50	39	38	46	42	37	475

3.2.2 Jumlah permintaan Tes HIV

Pelaksanaan tes HIV diselenggarakan dalam bentuk *Voluntary Counseling and Testing (VCT)* maupun *Provider Initiated Testing and Counseling (PITC)*. Setiap pasien yang akan menjalani tes HIV terlebih dahulu mendapatkan konseling pra-tes oleh tenaga kesehatan. Konseling ini mencakup pemberian informasi mengenai HIV/AIDS, cara penularan, manfaat dan risiko pemeriksaan, serta jaminan kerahasiaan hasil tes. Setelah itu, pasien diminta memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) secara tertulis. Pengambilan sampel darah dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta keselamatan pasien.

Pemeriksaan HIV dilakukan menggunakan metode yang telah tervalidasi dan mengikuti algoritma tes HIV nasional. Untuk pasien dengan hasil reaktif, dilakukan konseling lanjutan yang mencakup edukasi, dukungan psikologis, serta rencana tindak lanjut berupa rujukan ke layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) termasuk terapi antiretroviral (ARV).

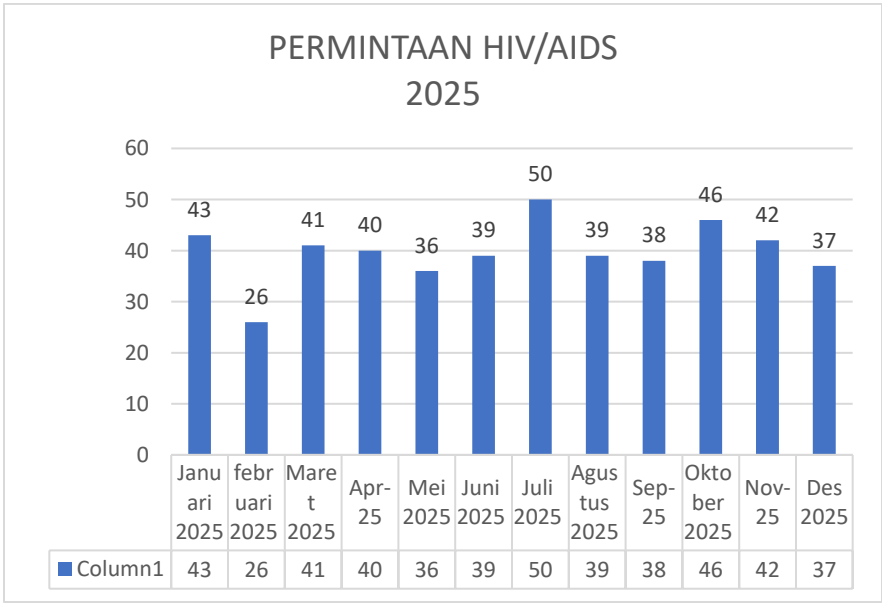
Berdasarkan hasil permintaan tabel data 3.3.1 diatas maka permintaan HIV per bulan sejak januari s/d desember 2025 bisa dilihat pada tabel 3.3.2 dibawah ini

Tabel 3.2.2

Jumlah permintaan tes HIV tahun 2025 (Januari s/d desember) di RS Prima Husada Sukorejo

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Permintaan Test HIV	43	26	41	40	36	39	50	39	38	46	42	37	477

GRAFIK 1
JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Tren permintaan layanan/pemeriksaan HIV/AIDS berfluktuasi dengan rata-rata bulanan di angka **39,8 (sekitar 40)** kasus/permintaan.

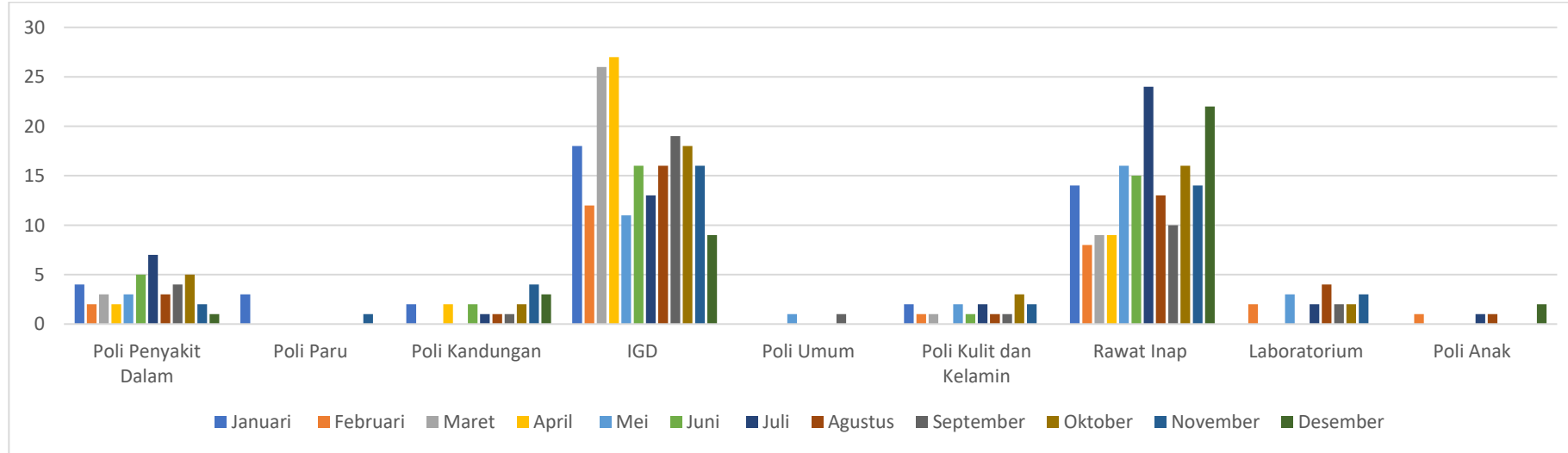
- 1. **Puncak Tertinggi:** Terjadi pada bulan **Juli (50)**. Hal ini mungkin berkaitan dengan adanya kampanye khusus atau skrining massal di periode tersebut.
- 2. **Titik Terendah:** Terjadi pada bulan **Februari (26)**, menunjukkan adanya penurunan signifikan hampir 40% dari rata-rata.
- 3. **Tren Akhir Tahun:** Setelah mencapai puncak kedua di Oktober (46), terjadi penurunan bertahap hingga Desember (37). Angka Desember berada di bawah rata-rata tahunan.
- 4. **Stabilitas:** Sebagian besar bulan (8 dari 12 bulan) berada di rentang 36-46, menunjukkan beban kerja yang relatif stabil namun perlu perhatian pada penurunan di akhir tahun.

Rencana Tindak Lanjut :

Tujuan utamanya adalah menstabilkan angka penjangkauan/permintaan dan memastikan tidak ada penurunan akses layanan.

- 1. **Evaluasi Penurunan:** Mengidentifikasi penyebab penurunan di bulan Desember (apakah karena faktor hari libur, ketersediaan logistik reagen, atau berkurangnya kegiatan lapangan).
- 2. **Penguatan Skrining:** Meningkatkan kembali kegiatan *Mobile Clinic* atau penjangkauan komunitas pada awal tahun 2026 untuk mengimbangi penurunan di akhir tahun.
- 3. **Manajemen Stok:** Memastikan ketersediaan alat tes HIV tetap aman untuk mengantisipasi lonjakan seperti yang terjadi di bulan Juli.

GRAFIK 2
JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025



Analisis

Berdasarkan grafik permintaan tes HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada tahun 2025, terlihat bahwa jumlah pemeriksaan HIV mengalami fluktuasi sepanjang tahun dengan kisaran antara 26 hingga 50 pemeriksaan per bulan. Puncak permintaan terjadi pada bulan Juli (50 pemeriksaan), sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Februari (26 pemeriksaan). Secara umum, tren menunjukkan peningkatan pada pertengahan hingga akhir tahun.

Dari analisis unit pelayanan, diketahui bahwa permintaan tes HIV/AIDS tertinggi berasal dari Unit IGD. Hal ini menunjukkan bahwa IGD berperan penting sebagai pintu masuk pasien dengan kondisi akut maupun kasus yang memiliki indikasi klinis untuk dilakukan tes HIV melalui pendekatan *Provider Initiated Testing and Counseling (PITC)*

Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan Implementasi PITC di IGD

- Menyusun dan memastikan penerapan SPO skrining HIV di IGD secara konsisten
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga kesehatan IGD
- Memastikan semua pasien dengan indikasi dilakukan penawaran tes HIV

2. Penguatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

- Optimalisasi pencatatan di rekam medis dan register HIV
- Monitoring bulanan jumlah tes per unit (terutama IGD)

3. Penguatan Alur Rujukan dan Tindak Lanjut

- Memastikan pasien dengan hasil reaktif langsung terhubung ke layanan PDP/ARV
- Koordinasi antara IGD, laboratorium, dan klinik VCT

3.2.3 STATUS HIV

Status HIV pasien di rumah sakit ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sesuai dengan algoritma tes HIV nasional dan didukung oleh proses konseling yang komprehensif.

Setiap pasien yang menjalani pemeriksaan HIV telah melalui tahapan konseling pra-tes, pemberian persetujuan tindakan medis (informed consent), serta pemeriksaan laboratorium yang tervalidasi. Hasil pemeriksaan diklasifikasikan menjadi:

- Non-reaktif, apabila tidak ditemukan antibodi HIV
- Reaktif, apabila ditemukan indikasi infeksi HIV dan telah sesuai dengan algoritma pemeriksaan nasional
- Inkonklusif, apabila hasil belum dapat ditentukan sehingga memerlukan pemeriksaan ulang

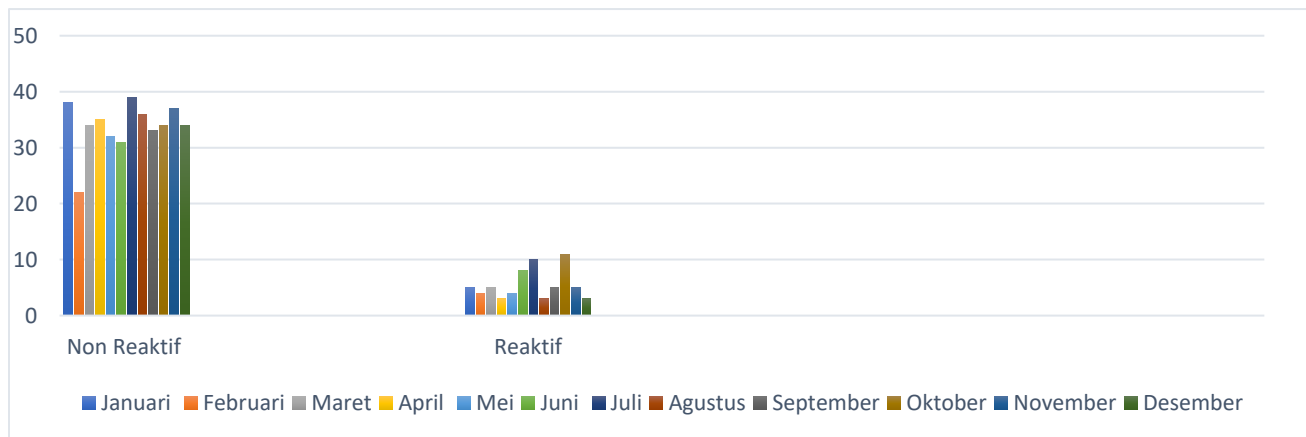
Bagi pasien dengan status HIV reaktif, rumah sakit memastikan adanya tindak lanjut pelayanan berupa rujukan atau integrasi ke layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) termasuk terapi antiretroviral (ARV). Selain itu, pasien juga mendapatkan edukasi terkait pencegahan penularan serta dukungan berkelanjutan.

Tabel 3.2.3

Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes HIV pada pasien yang dilakukan skrining dari bulan Januari s/d Desember tahun 2025 di RS Prima Husada Sukorejo

No	HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
	Jumlah pasien yang dilakukan skrining	43	26	41	40	36	39	50	39	38	46	42	37	
	Total yang melaksanakan pemeriksaan laboratorium	43	26	41	40	36	39	50	39	38	46	42	37	
1	Non Reaktif	38	22	34	35	32	31	39	36	33	34	37	34	405
2	Reaktif	5	4	5	3	4	8	10	3	5	11	5	3	66

GRAFIK 3
STATUS HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025



Analisis Status HIV

Berdasarkan data status HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada tahun 2025, diperoleh bahwa dari seluruh pasien yang dilakukan pemeriksaan HIV:

- Sebanyak 405 pasien ($\pm 86\%$) berstatus non reaktif
- Sebanyak 66 pasien ($\pm 14\%$) berstatus reaktif

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien yang diperiksa tidak terinfeksi HIV, namun terdapat proporsi kasus reaktif yang tetap signifikan dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganan dan pengendalian.

Tingginya jumlah hasil non reaktif mengindikasikan bahwa:

1. Program skrining HIV di rumah sakit telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari deteksi dini
2. Kesadaran pasien dan tenaga kesehatan terhadap pentingnya pemeriksaan HIV cukup tinggi
3. Implementasi layanan VCT dan PITC telah menjangkau populasi yang lebih luas

Sementara itu, ditemukannya 66 kasus reaktif menunjukkan:

1. Masih adanya penularan HIV di masyarakat
2. Peran rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting dalam menemukan kasus baru (case finding)
3. Layanan skrining telah tepat sasaran, terutama pada kelompok berisiko atau dengan indikasi klinis

Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan Tindak Lanjut Kasus Reaktif

- Memastikan seluruh pasien dengan hasil reaktif (66 pasien) mendapatkan:
- Konseling pasca-tes secara komprehensif
- Pemeriksaan lanjutan sesuai algoritma nasional
- Akses ke layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP)
- Inisiasi terapi ARV secepatnya

2. Penguatan Edukasi dan Pencegahan

- Edukasi pasien non reaktif (405 pasien) terkait:
- Perilaku hidup sehat
- Pencegahan penularan HIV
- Program promosi kesehatan rumah sakit (PKRS) terkait HIV/AIDS

3. Penguatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

- Pencatatan lengkap di rekam medis
- Pelaporan ke sistem surveilans HIV nasional
- Menjamin kerahasiaan status pasien

3.2.4 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

Dalam upaya menjamin kesinambungan pelayanan HIV/AIDS yang komprehensif, rumah sakit menetapkan mekanisme rujukan untuk pemeriksaan lanjutan yang belum tersedia di fasilitas internal, khususnya pemeriksaan viral load dan Early Infant Diagnosis (EID) pada bayi. Dalam rangka pemantauan keberhasilan terapi ARV, rumah sakit melaksanakan pemeriksaan *viral load* secara berkala sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan *viral load* dilakukan untuk mengukur jumlah virus HIV dalam darah pasien sebagai indikator keberhasilan pengobatan, kepatuhan terapi, serta deteksi dini kemungkinan kegagalan terapi ARV.

Bayi yang lahir dari ibu ODHIV mendapatkan pelayanan sesuai standar PPIA, termasuk pemberian profilaksis ARV, pemantauan tumbuh kembang, dan pemeriksaan *Early Infant Diagnosis (EID)*. Pemeriksaan EID dilakukan melalui pengambilan sampel darah kering (*Dried Blood Spot/DBS*) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam pedoman nasional guna mendeteksi infeksi HIV pada bayi sedini mungkin. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh dokter untuk menentukan tata laksana selanjutnya, termasuk pemberian terapi ARV apabila bayi terkonfirmasi HIV.

RSUD Dr. Saiful Anwar dan RSUD Bangil dipilih sebagai fasilitas rujukan karena memiliki layanan HIV yang lengkap, termasuk pemeriksaan viral load untuk monitoring keberhasilan terapi antiretroviral (ARV) serta layanan EID untuk diagnosis dini HIV pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Pemeriksaan viral load sangat penting untuk menilai keberhasilan pengobatan dan kepatuhan terapi, sedangkan EID dilakukan pada bayi usia dini untuk memastikan status infeksi secara cepat dan akurat.

Proses rujukan dilakukan secara terstandar dengan tahapan sebagai berikut:

- Pasien atau orang tua bayi mendapatkan konseling terkait tujuan dan pentingnya pemeriksaan lanjutan
- Petugas memastikan koordinasi dengan fasilitas rujukan untuk kelancaran pelayanan
- Menjamin kerahasiaan status HIV pasien dan bayi selama proses rujukan

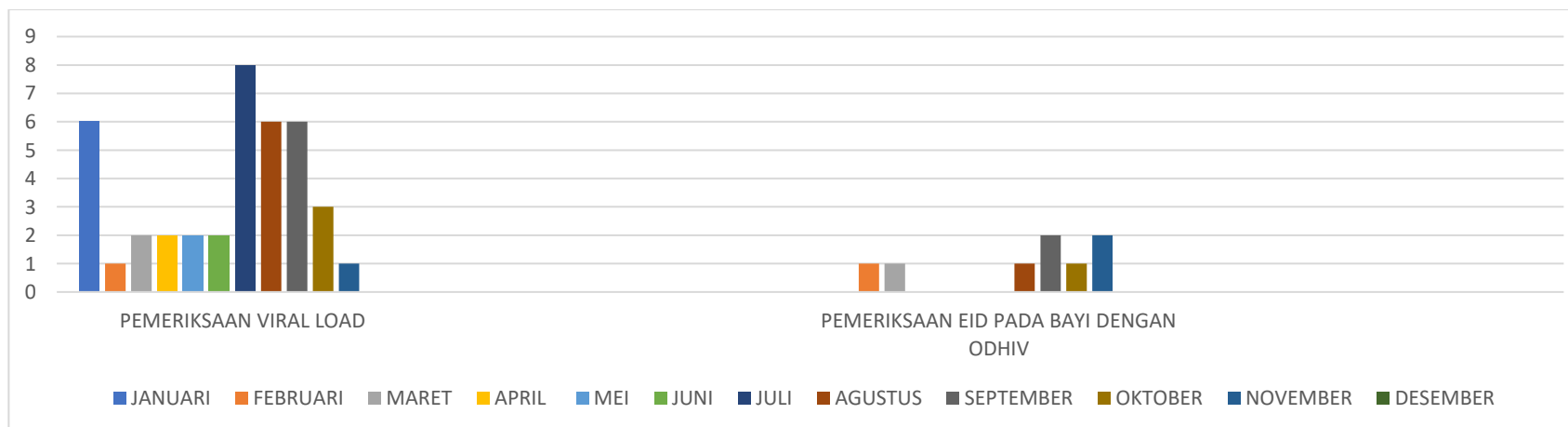
Dalam pelaksanaannya, rumah sakit juga memastikan adanya sistem tindak lanjut (feedback rujukan) untuk memantau hasil pemeriksaan viral load maupun EID bayi, sehingga pelayanan dapat berkesinambungan dan terintegrasi dengan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) di fasilitas asal.

Dengan adanya rujukan ke RSUD Dr. Saiful Anwar dan RSUD Bangil sebagai rumah sakit rujukan pemeriksaan viral load dan EID bayi, diharapkan pasien dan bayi dengan risiko HIV mendapatkan pelayanan yang tepat, cepat, dan berkesinambungan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien

Tabel 3.2.4

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pemeriksaan Viral Load													
	Poli VCT	6	1	2	2	2	2	8	6	6	3	1	0	39
2	Pemeriksaan EID	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	2	0	8

GRAFIK 11
PEMERIKSAAN VIRAL LOAD PADA PASIEN HIV DAN EID PADA BIHA
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS

Dari hasil grafik diatas data pelayanan pemeriksaan *viral load* pada pasien HIV dan pemeriksaan *Early Infant Diagnosis (EID)* pada bayi dari ibu ODHIV di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025, diperoleh hasil bahwa jumlah pemeriksaan *viral load* yang dilakukan melalui Poli VCT selama periode Januari sampai Desember sebanyak 39 pemeriksaan. Sementara itu, pemeriksaan EID pada bayi dengan ibu ODHIV selama tahun 2025 tercatat sebanyak 8.

Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Rujukkan dilakukan apabila terdapat pemeriksaan Viral load pada pasien HIV dan Eid pada bayi dengan ibu Odhiv. Rujukkan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, maka direncanakan tindak lanjut sebagai berikut:

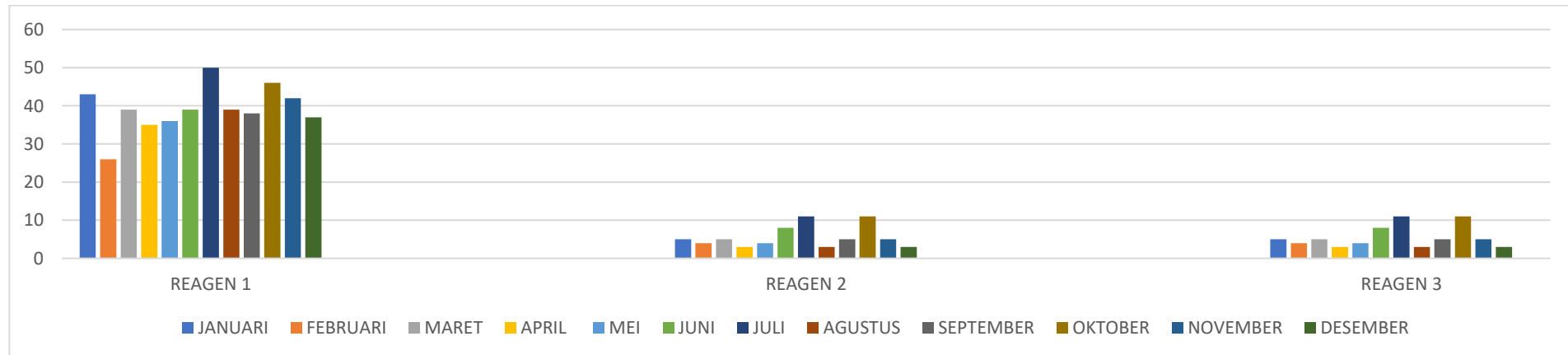
1. Meningkatkan skrining dan penjadwalan pemeriksaan *viral load* secara berkala pada pasien HIV/AIDS sesuai pedoman nasional untuk memastikan keberhasilan terapi ARV.
2. Memperkuat edukasi dan konseling kepada pasien HIV/AIDS terkait pentingnya kepatuhan pengobatan dan pemeriksaan rutin *viral load*.
3. Mengoptimalkan koordinasi antara Poli VCT, laboratorium, farmasi, ruang perawatan, dan unit terkait dalam kesinambungan pelayanan HIV/AIDS.
4. Meningkatkan pelaksanaan program PPIA melalui deteksi dini ibu hamil HIV, pendampingan terapi ARV pada ibu hamil, serta pemantauan bayi sampai jadwal pemeriksaan EID terpenuhi.
5. Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, bahan habis pakai, dan sistem rujukan laboratorium untuk mendukung pelayanan pemeriksaan *viral load* dan EID.

3.2.4 Logistik

Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Reagen 1	43	26	39	35	36	39	50	39	38	46	42	37	470
2	Reagen 2	5	4	5	3	4	8	11	3	5	11	5	3	67
3	Reagen 3	5	4	5	3	4	8	11	3	5	11	5	3	67

GRAFIK 4
JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025



Analisis jumlah pemakaian reagen

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada tahun 2025 sampai dengan reagen 3.

Rencana Tindak Lanjut

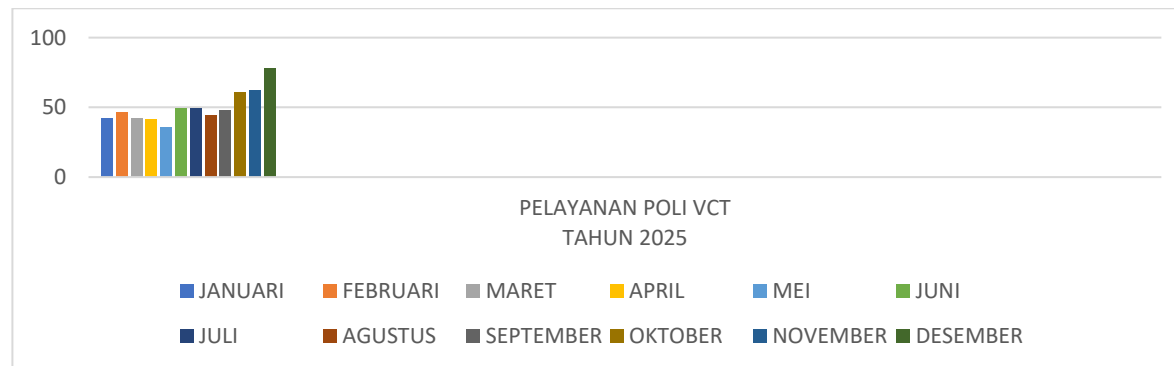
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.2.5 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan Poli VCT	42	46	42	41	36	49	49	44	48	61	62	78	598

GRAFIK 5
PELAYANAN POLI VCT DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa kunjungan pada Poli VCT Rs Prima Husada Sukorejo tahun 2025 Total 598 kunjungan. Dan pada bulan Desember 2025 sebagai kunjungan pasien terbanyak yaitu 78 pasien HIV yang sedang pengobatan dan mulai masuk perawatan. Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebagai kunjungan terendah yaitu sebanyak 36 pasien HIV yang sedang pengobatan dan mulai masuk perawatan.

Rencana Tindak Lanjut

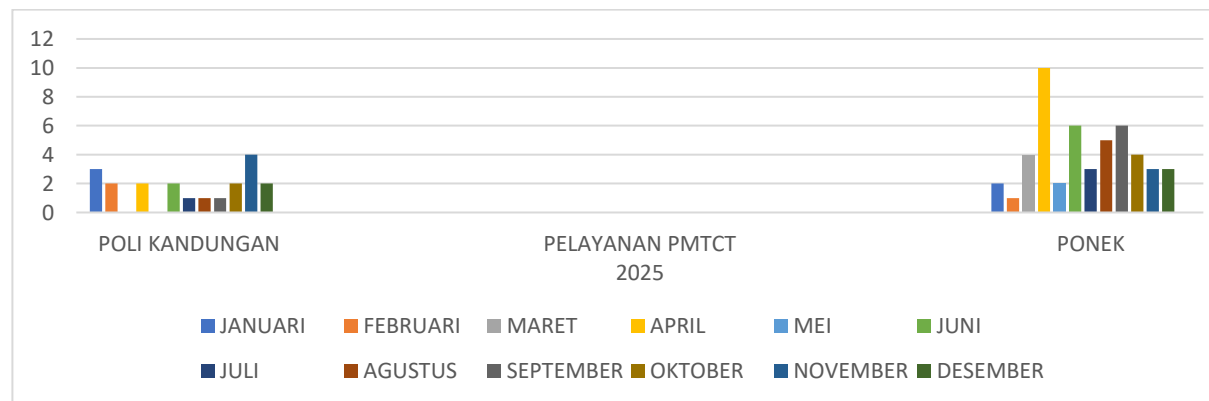
Sebagai rumah sakit penyelenggara layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di Kabupaten Pasuruan, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo perlu meningkatkan;

1. Penguatan Tata Kelola Pelayanan HIV
2. Peningkatan kompetensi SDM
3. Penguatan Layanan PDP HIV
4. Indikator Monitoring dan Evaluasi

3.2.6 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan PMTCT													
	Poli Kandungan	3	2	0	2	0	2	1	1	1	2	4	2	15
	Ponek	2	1	4	10	2	6	3	5	6	4	3	3	49

GRAFIK 7
PELAYANAN PMTCT DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025



Analisis : Pelayanan PMTCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada tahun 2025 sebanyak 64 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan dan ponek RS Prima Husada Sukorejo sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Sukorejo untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bisa dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Sukorejo sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bisa dilakukan.

3.2.7 Pelayanan ODHA Dengan IO Factor Resiko Infeksi Oportunistik

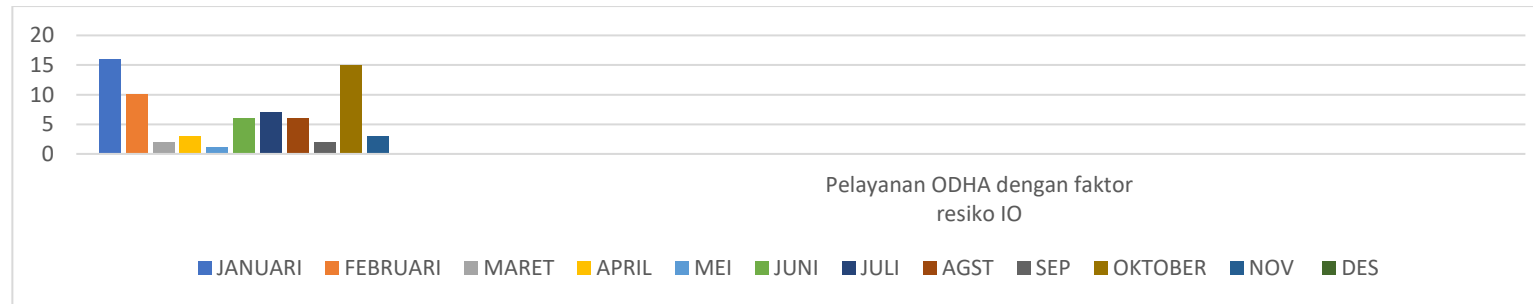
Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai layanan PDP HIV Kabupaten Pasuruan, pelayanan ODHA dengan faktor risiko IO telah berjalan melalui layanan rawat jalan, rawat inap, konseling, dan kolaborasi program TB-HIV.

Pasien HIV dengan kondisi imunitas rendah, keterlambatan memulai ARV, kepatuhan pengobatan yang buruk, status gizi kurang, serta komorbid seperti TB dan hepatitis memiliki risiko tinggi mengalami IO. Dalam beberapa kasus masih ditemukan pasien datang dalam kondisi stadium lanjut dengan infeksi oportunistik berat akibat keterlambatan diagnosis HIV maupun keterlambatan rujukan.

Tabel 3.2.7

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	16	10	2	3	1	6	7	6	2	15	3	3	74

GRAFIK 10
PELAYANAN ODHA DG FAKTOR RESIKO IO (Resiko Infeksi Oportunistik)DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025



Analisis pelayanan Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat 74 pasien ODHIV dengan faktor resiko IO (Infeksi Oportunistik), grafik tertinggi ditemukan pada bulan Januari 2025 dengan total sebanyak 16 orang, sedangkan grafik ter rendah ditemukan pada bulan Mei 2025 dengan total sebanyak 1 orang. IO yang paling banyak ditemukan yaitu HIV dengan candidiasis oral, HIV dengan TB positif, HIV dengan Toxoplasma cerebri, dan HIV dengan sifilis.

Rencana Tindak Lanjut

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.2.8 Promosi kesehatan program HIV AIDS

Kegiatan pelayanan promosi kesehatan ada 2 macam yaitu :

a. Edukasi (KIE)

KIE pada pasien HIV/AIDS adalah kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang diberikan kepada pasien HIV/AIDS, keluarga, maupun pendamping untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk perilaku sehat, meningkatkan kepatuhan terapi, serta mencegah penularan HIV dan komplikasi penyakit.

[illegible]

Analisis :

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung, dapat dianalisis bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan target. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sasaran yang mencapai target kehadiran serta keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sasaran yang mencapai target kehadiran serta keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan konseling Pasien dengan Hasil HIV positif dan Masuk Pengobatan ART	3	1	1	3	1	4	6	2	2	7	0	0	30

Analisis :

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelayanan konseling pada pasien dengan hasil Laboratorium HIV Positif/Reaktif kemudian langsung masuk pengobatan ART pada kunjungan Januari 2025 – Desember 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, diperoleh bahwa;

- Sebanyak 30 pasien memulai masuk pengobatan ART
- Kunjungan terbanyak pada bulan Oktober 2025, sebanyak 7 pasien
- Kunjungan terendah pada bulan November dan Desember 2025, yaitu 0 kunjungan

[illegible]

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan tahunan Tim HIV-AIDS RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2023. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Mengetahui
Ketua Tim HIV-AIDS

Pasuruan, 03 Januari 2026
Sekretaris Tim HIV-AIDS



dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp. PD



Vira Agustin Sintia Putri, A.Md Kep

Mengetahui
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep